

육군 간부들의 스트레스 유형 분석 및 자살 행동과 우울증과의 관련성 연구[†]

이현엽*, 현승주**, 최윤영***, 기호연****, 강성록*****

- I. 서론
- II. 이론적 배경 및 연구 목적
- III. 연구 방법
- IV. 연구 결과
- V. 논의

Abstract

Dimensionality of the military stress and their associations with suicidal behaviors and depression among the ROK Army officials

This study aimed to classify the types of stress among the ROK Army officers and NCOs, and to examine their associations with suicidal behaviors and depression. Data were collected from 500 military officials, who responded to a self-rated questionnaire. Factor analyses using exploratory structural equation modeling supported the superiority of the six-factor model consisting of task, organizational culture, work environment, interpersonal relationship, familial affairs, and personal matters. Next, hierarchical analyses were conducted to ascertain the unique impacts of subtypes of military stress, after controlling the effects of demographics and protective factors, gratitude and social support. The results showed that interpersonal relationship stress had unique impacts on suicidal behaviors and depression among junior military officials. Among senior military officials, however, task stress and interpersonal relationship stress were found to be independently associated with depression. These findings indicate that the impacts of subtypes of military stress can vary depending on military position, and counseling interventions for military officials should be more focused on mitigating interpersonal relationship stress.

Keywords: military stress, suicidal behaviors, depression, military officials

[†] 본 논문은 육군사관학교 미래전략기술연구소의 연구활동비 지원을 받아 수행되었음. (24-가치문화연구소-08)

* 육군사관학교 심리경영학과 교수, c14328@gmail.com

** 육군사관학교 심리경영학과 조교수, hyunyoonyoon5997@gmail.com

*** 육군사관학교 심리경영학과 부교수, azure25@gmail.com

**** 육군사관학교 심리경영학과 강사, 1-10102@kma.ac.kr

***** 육군사관학교 심리경영학과 교수, ksr6452@gmail.com

I. 서론

2014년부터 2022년까지 군 사망사고 현황 분석결과 사망사고 원인 1위는 자살사고(연평균 약 64건)였으며, 전체 사망사고 중 약 74%를 차지했다(e-나라지표, 2024). 이는 일반 국민 20세 이상 성인 기준 인구 10만 명당 자살률(지표누리, 2024)과 비교하면 비록 낮은 수준이지만, 자살사고는 가족들의 심리적 건강뿐만 아니라 부대 사기 및 정신전력에 심각한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 점에서 군 연구자들은 자살 예방을 위한 연구(위험요인과 보호요인 검증)를 진행해왔다(예: 김재엽·최유일, 2021; 정신영·이동귀, 2012; 홍점동·양난미, 2013). 한편 우울증은 자살 행동과 높은 관련성을 나타내는 정신질환으로 알려져 있으며(Grossberg & Rice, 2023), 우리나라 군인들의 경우 2012~2016년 동안 군 병원에서 진료받은 정신질환 중 일반정신과적 문제¹⁾와 적응장애를 제외하고 우울장애가 가장 많았다(정승원, 2016). 2018~2022년에도 우울증은 군 병원에서 진료받은 군인들의 주요한 정신질환이었다(신은진, 2023). 이에 군 장병들을 대상으로 우울증을 예측하는 요인들을 검증하거나 자살 행동과의 관련성을 검증한 연구들도 꾸준히 진행되어왔다(박선영·김경미, 2013; 이영선, 2014).

심리적으로 취약한 군인들의 정신건강 증진을 위해 학문적 연구뿐만 아니라 상담 관련 정책을 시행하거나 관련 프로그램도 개발되어왔다. 예를 들어, 장병들의 군 복무 부적응을 해소하고 자살 등 각종 사고를 예방하기 위해 병영생활전문상담관이 대대·여단급 부대까지 배치되어 상담 서비스를 제공하고 있으며(국방부, 2024), 육군 군단급 제대에서는 군 복무 부적응 병사들의 심리적 적응 향상을 위한 그린캠프를 운영하고 있다(박찬희, 2020). 비록 소수이기는 하지만 병영생활전문상담관제도와 그린캠프의 긍정적 효과성을 밝힌 연구들도 진행되었다(김영태·이현엽, 2009; 장기수, 2013).

그런데 앞서 살펴본 군인들의 정신건강 증진을 위한 연구들과 프로그램들은 주로

1) 명확한 진단명이 밝혀지지 않은 상태에서 지속적인 치료를 받은 경우에 해당함

병사들에게 초점이 맞추어져 왔다. 2018~2022년 동안 정신질환으로 진료받은 인원 중 병사들이 80%를 차지했고(신은진, 2023), 2017년 이후 5년 6개월간 약 3만 1,300명의 병사가 정신질환 및 복무 부적응 등의 사유로 중도 전역한 점(정충신, 2022), 병영 부조리와 심리적 부적응으로 인해 다수의 군인이 목숨을 잃은 2005년, 2011년, 2014년의 전방부대 총기난사 사건(구승신·윤호순, 2016) 등을 고려하면, 군내 정신건강 관련 연구와 프로그램들이 병사들에게 주된 관심을 두어온 것은 자연스러워 보인다.

그러나 최근 간부들의 정신건강에도 관심을 가져야 함을 보여주는 자료가 제시되고 있다. 2023년 국회에 보고된 국방부 자료에 따르면 최근 5년 동안 간부들의 자살사고 인원이 병사들보다 많았는데, 구체적으로 준·부사관 비율(43%)이 가장 높았으며 이어서 병사(37%), 장교(14%), 군무원(6%) 순으로 나타났다(조성신, 2023). 또한 2017~2022년 국방 헬프콜에 접수된 병영생활 고충 상담 유형에서도 간부들의 복무 부적응, 정신건강, 자살 충동으로 인한 상담 건수가 전반적으로 증가하였으며,²⁾ 특히 2020년 이후 복무 부적응 상담 건수가 2배 이상 증가하였다(국방부, 2023).

이처럼 간부들의 정신건강 위험성이 증가하고 있지만, 자살 예방 및 심리적 건강 증진을 위한 연구들은 많이 진행되지 않고 있다. 비록 간부들의 자살 행동과 정신건강을 예측하는 변인들을 검증하는 연구들이 소수 진행되어 오긴 했으나, 주로 통합적 관점에서 스트레스와 보호요인들(예: 사회적 지지 등)의 관련성을 분석했다(박승일·이동귀, 2014; 최정민 등, 2021). 그러나 군에서 경험하는 스트레스 유형이 다양할 수 있음을 고려할 때(예: 대인관계, 조직문화, 근무 환경 등) 간부들의 자살 행동 및 정신건강과의 관련성을 나타내는 구체적인 스트레스 유형이 무엇인가에 관해서는 추가적인 연구가 필요하다. 스트레스 요인 자체보다는 스트레스에 대한 평가 및 대처에 따라 그 결과가 달라지기에 개인의 내·외적 대처 자원이나 스트레스로

2) 2017년 복무 부적응, 정신건강, 자살 충동 상담 건수는 각각 418건, 26건, 25건이었으며 2022년에는 각각 1,035건, 130건, 54건이었음. 연도별 구체적인 상담 건수는 2023년 국방통계연보에서 확인할 수 있음.

인한 반응에 중점을 두고 연구를 진행하기도 하지만(Aldwin, 2017), 본 연구는 군 간부들이 경험하는 스트레스의 구체적 원인(요인)을 알아보고, 이러한 요인들과 정신건강과의 관련성을 검증함으로써 정책적·상담적 개입 시 어떤 스트레스 유형에 중점을 두어야 하는가에 관한 시사점을 제시하는 데 목적을 두었다. 또한, 군에서 직급별로 수행하는 임무와 역할이 다를 수 있음을 고려하여 군에서의 스트레스 유형과 자살 행동, 정신건강의 관련성이 집단(예: 초급간부, 중견간부)에 따라 다르게 나타나는지도 검증할 필요가 있다. 단순히 군 간부들의 자살사고를 예방하고 심리적 건강을 위해 스트레스를 감소시킬 필요가 있다는 포괄적 결론보다는 세부적으로 어느 유형의 스트레스가 강한 관련성을 갖고 있고, 이러한 관련성에서 집단에 따라 차이가 있는지 밝혀야 군 간부들에 대한 상담적 개입 및 프로그램을 진행할 때 필요한 유용한 정보를 제공할 수 있기 때문이다.

Ⅱ. 이론적 배경 및 연구 목적

1. 자살 행동과 정신건강의 위험요인 : 스트레스

스트레스는 신체적, 정신적 건강과 직·간접적으로 연결되어 있으며, 다양한 경로를 통해 자살 행동에 영향을 미치는 주요한 위험요인으로 알려져 있다(박승일·이동귀, 2015; Aldwin, 2007). 또한, 스트레스는 심리적 긴장과 부정적 정서의 수준을 증가시키고 긍정적 정서와 주관적 안녕의 수준을 감소시키며(김윤희 등, 2015), 우울증 등 부정적인 정신건강에도 유의한 영향력을 미친다(Aldwin, 2007). 자연재해나 기술재해, 환경재해 등과 같이 사람들에게 거의 동일하게 영향을 미치는 스트레스도 있지만, 발달단계나 사회문화적 특성으로 인해 특정한 집단 사람들에게 집중적으로 나타나는 스트레스도 있다(Aldwin, 2007). 예를 들어, 대학생은 학업 부담, 취업 준비, 새로운 환경과 인간관계에 적응해야 하는 스트레스를 경험한다(전경구 등, 2000). 군인들도 엄격한 질서와 상명하복의 중시, 강한 집단적 속성 등

군 조직의 특수성과 환경에서 비롯되는 다양한 스트레스를 경험하게 된다(권승재, 2001; 유태현, 2004). 특히 간부들은 부하를 관리하고 훈련시켜야 하며, 일반 공공기관 근무자들과 비교하여 열악한 환경을 참고 견뎌야 할 때가 많다. 또한, 기혼 간부의 경우 가족과 떨어져 장기간 지내는 경우가 발생하며, 직업군인의 특성으로 인해 인사평가 및 진급과 관련된 스트레스를 경험하기도 한다.

이러한 특수성을 고려하여 문호석과 강성록(2016)은 육군본부 실무자와 토의를 거쳐 기존 병사들을 대상으로 개발한 스트레스 척도(강성록 등, 2012) 문항 중 간부들에게 적용할 수 있는 문항을 수정·보완하여 30개 문항으로 구성된 간부 스트레스 척도를 개발한 후 신분별, 계급별, 성별로 차이가 있는지 분석하였다. 그 결과 전반적으로 부사관보다 장교의 스트레스 수준이 높게 나타났으며, 초급간부는 중견간부에 비해 상대적으로 높은 스트레스 수준을 나타냈다. 성별 비교에서는 남군보다 여군이 불시 업무, 업무량과 업무 적응, 업무 능력, 상관과의 의사소통과 동료 관계에서 더 높은 수준의 스트레스를 나타냈다(문호석·강성록, 2016).

한편 질적 연구 방법을 이용하여 간부들의 스트레스 유형을 분석한 연구도 진행되었다. 예를 들어, 최현주와 이자영(2012)은 부사관 대상 심층 면접을 통해 병사 및 부하 관리, 대인 갈등, 위계적인 군 조직 특성 측면에서 스트레스를 경험함을 밝혔다. 박일 등(2013)은 육군에서 5년 이상 복무한 12명의 현역 장교와 예비역 장교를 대상으로 Q 방법론을 이용하여 분석한 결과, 진급, 보여주기식 전시효과, 조직문화, 상명하복의 문화, 환경적 제약, 암묵적 차별, 불충분한 보상 및 지원 측면에서 스트레스를 경험함을 확인하였다. 그리고 연구를 위해 개발한 것은 아니지만 국방부에서 시행 중인 군 간부 및 군무원 민간 심리상담 지원 프로그램을 운영하는 민간 상담 기관에서는 간부들의 심리진단을 위해 34개의 통합직무스트레스 문항을 선정하여 이용하고 있다[(주)휴노, 2023].

이같이 간부들이 군 생활에서 경험하는 스트레스 유형은 다양할 수 있으며 신분 및 계급별로 경험하는 스트레스 수준도 다를 수 있다. 그러나 각 스트레스 유형이 자살 행동이나 정신건강에 차별적인 영향력을 나타내는가에 대해서는 추가적인 연구가 필요하다. 예를 들어, 가족 갈등은 자살 행동과 유의한 관련성을 나타냈으나,

직무 스트레스가 포함된 다중 회귀분석에서는 가족 갈등의 유의한 영향력이 없었다(김재엽·최유일, 2021). 또한, 역할 갈등으로 인한 스트레스(이자영, 2015)나 직무 스트레스(박승일·이동귀, 2014)가 간부들의 우울 증상과 유의한 정적 상관관계를 나타냈는데, 다른 유형의 스트레스(예: 조직문화, 개인문제 등)와 정신건강과의 관련성에 대해서는 아직 알려진 바가 없다. 그리고 신분에 따라 스트레스의 수준이 다를 수 있음을 고려하여(문호석·강성록, 2016), 신분에 따라 정신건강에 영향을 미치는 스트레스의 영향력이 다른지도 검증할 필요가 있다.

2. 자살 행동과 우울증의 보호요인 : 감사성향과 사회적 지지

스트레스가 자살 행동 및 정신건강의 주요한 위험요인으로 작용하지만, 이를 완충해주는 보호요인이 존재할 때 스트레스의 부정적 영향력은 감소될 수 있다(Aldwin, 2007). 이에 본 연구에서는 개인 내적 차원과 사회적 관계 차원에서 대표적인 보호요인으로 작용할 수 있는 감사성향과 사회적 지지를 포함하여 연구를 진행했다.

먼저 감사는 “자신에게 이익을 준 특정 대상을 인식함으로써 발생하는 긍정적인 정서”로(노지혜·이민규, 2011, p. 160), 비교적 지속적이고 안정적인 정서 특성을 나타낸다(Wood et al., 2009). 즉 긍정적 사건을 경험하거나 긍정적 결과를 얻은 상황에서 타인의 공헌을 인식하고 고마운 마음으로 반응하는 일반화된 경향성을 의미한다(McCullough et al., 2002). Fredrickson(2001)의 긍정 정서 확장 및 확립 이론(broaden-and-build theory of positive emotions)에 따르면, 감사와 같은 긍정 정서의 경험은 우울을 느낄 수 있는 상황에서 그 심각성을 낮추게 한다. 또한, 해결 가능한 대안을 찾도록 긍정적 사고를 확장시키고, 개인의 긍정적 자원을 활용하여 적응적 행동을 하도록 돕는다. 따라서 스트레스 상황에서도 감사한 사건을 상기하는 것은 삶의 적응성을 증가시키는 데 도움이 된다. 감사성향의 긍정적 영향을 검증한 연구들에 따르면, 감사하는 마음을 가질수록 우울, 신경증, 외로움 등 심리적 증상 수준이 낮았으며(Emmons, 2007), 삶의 만족도 및 긍정 정서, 행복감, 삶에서의

적응성 등 정신적 웰빙 수준은 더욱 높았다(이지은 등, 2016; Emmons & McCullough, 2003). 자살과의 관련성을 검증한 연구에서도, 임상(황지현·채정호, 2017) 및 비임상(최지영·이민규, 2016) 표본에서 감사를 더 많이 할수록 자살 생각이 유의하게 낮았다.

감사성향은 군인들의 적응력을 돕고 정신건강에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, 감사는 어려움에 직면했을 때 부정적인 상황을 재평가하여 극복하는데 도움을 주며 그릿(grit)을 높이는 작용을 하기에(Gabana et al., 2022), 육체적·정신적으로 힘든 군사훈련이나 업무수행 시 능동적으로 대처할 수 있도록 도울 수 있다. 또한, 감사는 역경이 되었던 사건을 회상할 때 긍정적인 측면을 인식하도록 하기에(Watkins et al., 2004), 군 스트레스 사건 이후에도 부정적 정서를 덜 경험하고 적응적 행동을 유지하게 할 수 있다. 베트남전 참전군인 연구에 따르면, 외상후 스트레스를 겪는 참전자와 외상후 스트레스를 겪지 않는 참전자 모두 감사 기분을 많이 경험할수록 긍정 정서와 친사회적 행동이 증가하는 것으로 나타났다(Kashdan et al., 2006).

사회적 지지는 가족, 친구, 동료 등 타인과의 관계를 통해 제공되는 긍정적 지원과 도움을 의미하며, 스트레스 상황에서 개인을 보호하고 이겨나갈 수 있게 하는 자원이다(Caplan, 1974; Dao et al., 2007). 사회적 지지는 우울증 등 정신건강뿐만 아니라 자살 행동의 주요 보호 요인으로 잘 알려져 있다(Hu et al., 2023; Roohafza et al., 2014). 군인 대상 연구에서도 사회적 지지는 부대 적응에 긍정적인 영향을 나타냈으며(전지경·이종형, 2007), 자살 행동의 주요한 보호 요인으로 작용하였다(정신영·이동귀, 2011). 또한, 자살 또는 타살을 목격한 사람들이 외상후 스트레스를 극복하는 과정에서 사회적 지지는 중요한 회복요인이었다(장재현·이기학, 2013). 베트남전 참전군인의 경우, 사회적 지지가 높을수록 우울 증상은 낮았으며(현혜순 등, 2018), 긍정적 측면의 정신적 웰빙 수준은 높았다(이현엽, 2022). 전투 노출을 경험한 미군을 대상으로 한 연구에서도 사회적 지지가 높을수록 우울 증상이 감소했으며(Proescher et al., 2020), 12개월 종단연구에서는 사회적 지지가 낮을수록 PTSD 수준과 자살 생각 수준이 더 높게 나타났다(Scoglio et al., 2022).

3. 연구 목적

통합적 관점에서 스트레스가 자살 행동 및 정신건강에 부정적인 영향력을 나타낸다는 것은 잘 알려져 왔으나, 본 연구는 세부적 관점에서 군 간부들의 ① 스트레스 유형을 분류하여, ② 각 스트레스의 유형과 자살 행동, 우울증과의 관련성을 검증하고, ③ 이러한 관련성에서 신분별로 차이가 나타나는지 분석하는 데 목적을 두었다. 그리고 ④ 보호요인으로 작용할 수 있는 감사성향과 사회적 지지의 영향력이 포함되었을 때 스트레스의 부정적인 영향력이 변화하는지도 탐색적으로 살펴보고자 했다.

문호석과 강성록(2016)은 간부들이 군 생활에서 경험하는 스트레스 요인을 30개 문항으로 정리하고 이를 4개의 유형으로 구분하였으나, 요인분석 등 과학적 검증을 통해 유형을 분류한 것이 아니라 설문 문항의 유사성에 기초하여 4개의 범주로 분류했다는 제한점이 있었으며 일부 유사한 문항이 있었다(예: 행정업무 부담으로 인한 스트레스 vs. 업무 능력으로 인한 스트레스). 또한, 질적 연구(박일 등, 2013; 최현주·이자영, 2012)들은 각각 소수의 장교 및 부사관을 대상으로 스트레스 요인을 파악하였고, 두 집단에 공통으로 적용하기 어려운 문항(예: ‘열심히 노력해서 장군 진급을 해도 행복할 것 같지 않다.’, ‘장교에 비해 경제적 처우가 미약하다.’)이 존재하였다.

이에 야전부대에서 중대급 지휘관과 대대급 참모 임무를 경험한 심리학자, 임상심리학 박사 및 정신보건 자격증을 갖춘 전문가, 군 스트레스 및 정신건강 분야 전문가로 구성된 연구진은 토의 과정을 통해 문호석과 강성록(2016)의 스트레스 문항을 기초로 하되, 질적 연구에서 공통으로 포함하고 있는 스트레스 요인을 선별하였다. 또한, (주)휴노(2023)에서 군 간부들의 심리진단을 측정하기 위해 사용하고 있는 직무 스트레스 문항 중 선행연구에서 자살 행동 및 정신건강과 관련되어 있다고 밝혀진 내용(예: 스마트폰 과의존, 온라인 게임 및 도박 행동, Richard et al., 2020; Shinetsetseg et al., 2022)을 참고하여 부록 1과 같이 최종 30개 문항으로 구성된 군 간부 스트레스 척도를 재정립하였다.

본 척도는 군 간부들의 스트레스를 측정하기 위해 새롭게 개발한 측정 도구는 아니며, 기존 연구에서 활용된 문항들을 이용하여 연구 목적에 맞게 재정립한 것이다. 따라서, 스트레스 척도 개발 과정 및 타당화 분석을 구체적으로 제시하기보다 간부들이 경험할 수 있는 스트레스 유형을 탐색적 차원에서 요인분석을 통해 분류하고, 자살 행동 및 우울증과의 관련성을 검증하는 데 목적을 두었다. 이때 본 연구가 자기 보고식 설문을 통해 진행됨을 고려하여 연구 대상자들이 설문 문항에 긍정적으로 응답하려는 사회적 바람직성(권희경·이현주, 2020)의 영향력을 통제하기 위해 이와 관련된 변수를 포함하여 연구를 진행했다.

Ⅲ. 연구 방법

1. 연구 대상

우리나라 육군 간부를 대상으로 2024년 6월 14일부터 6월 30일까지 설문을 통해 연구 자료를 수집하였으며, 총 500명이 응답한 자료를 본 연구에서 사용했다. 설문 조사에 앞서 군 기관에서 보안성 검토 및 승인을 받았으며, 국군의무사령부 의학연구 윤리심의위원회로부터 연구에 대한 승인을 받았다(IRB number: AFMC 2024-04-003-001). 육군본부로부터 연구 진행에 대한 최종 승인을 받은 이후 전방 2개 사단, 후방지역 1개 사단 및 1개 여단 등 총 4개 부대에서 설문 조사를 진행했다. 연구팀은 4개 부대 인사업무 실무자와 유선 연락을 통해 설문 진행 가능 일자를 조율하였으며, 설문 인원은 부대별로 200명을 요청하였다. 이때 설문 대상은 현역 장교, 부사관, 준사관으로 한정하였으며 군무원, 임기제 부사관, 대령 이상 장교는 연구 대상에 제외하였다. 각 부대 설문 인원 구성은 계급별 비율에 따라 편성하되, 보병 병과 50%, 보병 제외 전투병과 25%, 기술 및 행정병과 25%로 구성할 것을 요청하였다.

설문 진행은 연구팀이 해당 부대에 직접 방문하여 실시했으며, 1개 부대는 상급부대 불시 점검으로 인해 대면 설문 조사가 불가능하였다. 이에 설문지를 인사실무자에 전달한 후 자체 설문 진행 후 연구팀에게 우편으로 발송하게 하는 방식으로 진행했다. 해당 부대를 방문하여 대면 설문 조사를 진행한 경우 연구의 취지를 직접 설명한 후 자발적으로 설문 응답에 참여할 것을 강조하였으며, 연구 참여 동의서 작성과 설문 응답이 완료되면 박스형 형태의 수거함에 직접 연구 참여자가 넣을 수 있도록 안내했다. 설문 응답은 무기명으로 진행되었으며, 설문 조사에 자발적으로 참여한 500명의 자료를 본 연구에서 사용했다. 부대별 설문 응답 인원은 A부대 136명, B부대 115명, C부대 107명, D부대 142명이었으며, 평균 나이는 $30.04(SD=7.4, range=18-52)$ 였다. 연구 참여자에 대한 기타 인구통계학적 자료는 <표 1>과 같다.

<표 1> 인구통계학 자료(N=500)

	구분	인원(명)	비율(%)
성별	남자	436	87.2
	여자	64	12.8
계급	하사	114	22.8
	중사	128	25.6
	상·원사	120	24.0
	준위	3	0.6
	소·중위	58	11.6
	대위	54	10.8
	소·중령	23	4.6
	미혼	304	60.8
	기혼 또는 사실혼	191	38.2
결혼상태	기타(사별 등)	5	1.0
	고등학교 졸업 또는 그 이하	85	17.0
	대학교 재학, 중퇴 또는 졸업	385	77.0
	대학원 이상	30	6.0

2. 측정 도구

가. 스트레스

군 생활 스트레스는 문호석과 강성록(2016)이 개발한 간부 스트레스 문항과 질적 연구에서 밝혀진 간부 스트레스 요인, 그리고 군 간부 심리상담 지원 프로그램을 운영하고 있는 ㈜휴노(2023)의 직무스트레스 문항을 참고하여 장교와 부사관, 초급 간부와 중견 간부 모두 응답 가능한 30개 문항으로 구성하였다. 이때 직책에 따라 응답하기 어려운 문항(예: 과다한 회의·보고 준비 시간 등)과 미혼 간부의 경우 해당하지 않는 문항(예: 자녀의 진로문제)은 삭제 및 수정하고, 질문이 모호한 문항은 최근 정신건강의 위험요인으로 밝혀진 문제적 행동으로 구체화하였다(예: 무절제한 개인 습관 → 온라인 게임 및 스마트폰 과다사용). 본 척도는 평소 군 생활을 하면서 어느 정도 스트레스를 경험했는지 5점 Likert 척도(0=전혀 아니다, 4=매우 그렇다)에서 평가하게 되어있다. 점수가 높을수록 스트레스를 높게 지각하고 있음을 나타낸다. 전체 문항에 대한 내적 합치도(Cronbach's α)는 .94였다.

나. 자살 행동

자살 행동은 Osman 등(2001)이 개발하고, 우리나라 국립정신건강센터(2020)에서 한국어로 제시한 자살 행동 질문지(Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised, 이하 'SBQ-R') 4개 문항으로 측정했으며, 문항별 채점 방식에 따라 응답 값을 코딩했다. 예를 들어, 1번(전혀 없다) ~ 6번(자살을 시도해본 적이 있고, 정말 죽고 싶었다) 사이에서 응답하는 자살 시도 문항의 경우, 1번과 2번에 응답한 경우 각각 1점과 2점을 부여하고, 3번과 4번에 응답한 경우는 3점을 부여한다. 그리고 5번과 6번에 응답한 경우는 4점을 부여한다. 본 연구에서는 4개 문항의 응답 값을 합산한 총점을 사용했으며, SBQ-R 전체 문항에 대한 내적 합치도(Cronbach's α)는 .79였다.

다. 우울증

우울증은 Spitzer 등(1999)이 개발하고 박승진 등(2010)이 한국어로 타당화한 우울증 선별도구(Patient Health Questionnaire-9, 이하 ‘PHQ-9’)를 사용하여 측정했다. 지난 2주 동안 우울 관련 증상 9개 문항에 대해 어느 정도 어려움을 겪었는지 4점 Likert 척도(0=없음, 3=거의 매일)에서 응답하게 되어있다. 본 연구에서는 9개 문항에 대한 응답 값을 합산한 총점을 사용하였으며, 전체 문항에 대한 내적 합치도(Cronbach's α)는 .85였다.

라. 감사성향

감사성향은 McCullough 등(2002)이 개발하고 권성중 등(2006)이 한국어로 타당화한 감사성향 척도 6개 문항을 이용하여 측정했다. 일상생활에서의 감사의 경험과 감사 표현을 측정하며, 7점 Likert 척도(1=전혀 그렇지 않다, 7=매우 그렇다)에서 응답하게 되어있다. 3번과 6번 문항 값은 역채점했으며, 각 문항의 응답 값을 합산한 총점을 사용했다. 본 연구에서 전체 문항에 대한 내적 합치도(Cronbach's α)는 .86이었다.

마. 사회적 지지

사회적 지지는 Wilcox(2010)가 개발하고, Lee 등(2022)이 한국어로 번안한 사회적 지지 척도 16개 문항을 이용하여 측정했다. 중요한 타인 지지, 가족적 지지, 사회 친구 지지, 군 친구 지지 등 4개의 하위척도로 구성되어 있으며, 5점 Likert 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)에서 응답하게 되어있다. 각 문항의 응답 값을 합산한 총점을 분석에서 활용하였으며, 전체 문항에 대한 내적 합치도(Cronbach's α)는 .94였다.

바. 사회적 바람직성

사회적 바람직성은 김용석(2010)이 개발한 사회적 바람직성 척도의 하위척도인 인상관리 8개 문항을 사용하여 측정했다. 인상관리는 자신의 이미지를 호의적으로 제시하려는 의식적인 성향을 의미하며(예: ‘나는 때로 자리에 없는 구성원을 흥분적이 있다.’), 자기 보고식 설문에서 자신의 상태를 실제보다 더 긍정적으로 보이게 하려는 응답 태도를 측정할 수 있다. 5점 Likert 척도(1=전혀 그렇지 않다, 5=매우 그렇다)에서 응답하게 되어있으며, 채점 방식은 김용석(2010)이 제시한 방식에 따라, 각 문항에서 1(전혀 그렇지 않다) 또는 2(그렇지 않다)에 응답한 경우 1점을 부여하고, 나머지 응답 값은 0점을 부여했다. 본 연구에서는 응답 값을 합산한 총점 값을 사용했으며, 전체 문항에 대한 내적 합치도(Cronbach's α)는 .83이었다.

사. 인구통계학적 변인

본 연구에서 사용한 인구통계학적 변인은 나이(연대기적 연령), 성별, 계급, 결혼 상태, 교육수준이었다. 계급은 초급간부(하사, 중사, 소·중위)와 중견간부(상·원사, 대위, 준위, 영관장교)로 구분하여 신분별 분석에서 활용했으며, 대령과 장군은 연구 대상자에 포함하지 않았다. 결혼상태는 독신과 기혼(사실혼 포함)으로 구분하였으며, 교육수준은 고등학교 졸업 및 그 이하, 대학교 재학/중퇴 및 졸업, 대학원 이상으로 측정하여 분석에서 활용했다.

3. 분석 방법

스트레스 유형의 요인 구조를 분석하기 위해 먼저 Kaiser-Meyer-Olkin(KMO) 값을 확인하고 Bartlett 구형성 검정을 실시했다. 이후 요인 수의 대략적인 범위를 살펴보기 위해 주관적인 발견법으로 사용되는 고유값(eigenvalue)이 1 이상인 요인의 개수를 확인하고, 평행선 분석(parallel analysis)을 진행했다. 이를 바탕으로 탐색

적 요인분석(Exploratory Factor Analysis, 이하 ‘EFA’)을 통해 적절한 요인 구조를 판단한 후, 안정된 요인 구조를 갖는 모형을 바탕으로 탐색적 구조방식 모형(Exploratory Structural Equation Modeling, 이하 ‘ESEM’)을 활용하여 더 엄격하게 요인 구조를 분석하였다. ESEM은 EFA와 확인적 요인분석(Confirmatory Factor Analysis)의 장점을 통합한 분석 방법으로, 측정오차 간 상관을 자유 모수로 추정하게 하며, 동시에 측정오차 간 발생하는 상관이 요인 구조 추정에 미칠 수 있는 영향력을 통제할 수 있어 EFA 분석보다는 요인 간 변별이 더 잘 이루어지는 장점이 있다(이순목 등, 2016).

요인 부하량(factor loading)이 .30 이하인 문항은 일반적으로 요인분석에서 수용되지 않음을 고려하여(Howard, 2016), ESEM 분석 시 요인 부하량이 .30 이하를 나타내는 문항은 제거하였다. ESEM에서 목표회전 방식(target rotation)을 적용하였으며, 모수 추정 방법은 최대우도(Maximum Likelihood) 방식을 사용했다. 또한, 수정지수(modification indices, 이하 ‘M.I.’)가 높고 문항 간 유사성이 식별될 경우 상관 잔차를 허용하였다. 적절한 요인 구조를 판정하기 위해 Hu와 Bentler(1999)가 제시한 바에 따라 RMSEA(root mean square error of approximation)는 .06 이하, SRMR(standardized root mean squared residual)는 .08 이하, CFI(comparative fit index)와 TLI(Tucker-Lewis index)는 .95 이상일 경우 모델적합도가 적절하다고 판단하였으며, 추가로 Vandenberg와 Lance(2000)가 제시한 CFI와 TLI가 .90 이상일 경우에도 수용 가능한 모델적합도로 판단하였다.

스트레스 유형에 대한 요인 구조 분석 이후, 일원 분산분석(One-way Analysis of Variance; 이하 ‘ANOVA’)을 통해 계급별로 스트레스 수준에서 차이가 있는지 검증했다. 이때 세부 계급별 차이를 분석하기 위한 사후 검증(Post-hoc)은 Scheffé test를 실시했다. 이어서 상관관계 분석을 통해 스트레스 유형과 연구 변수들 간의 관련성을 살펴보았으며, 마지막으로 위계적 회귀분석을 통해 자살 행동과 우울증에 영향을 미치는 예측 변인들의 차별적 영향력을 분석하였다. 1단계 분석 시 인구통계학적 변수인 나이, 성별, 계급, 결혼상태, 교육수준과 설문에 대한 성실도를 반영할 수 있는 사회적 바람직성 변수를 통제변수로 투입하고, 요인분석을 통해 분류된

각 스트레스 유형은 주요 예측변수로 포함했다. 2단계 분석에서는 감사성향, 사회적 지지를 추가로 투입한 후 보호요인의 영향력을 통제한 후에도 스트레스의 영향력이 존재하는지 살펴보았다. 스트레스 하위유형들이 예측변수로 같이 투입됨을 고려하여 분산팽창지수(Variance Inflation Factor; 이하 ‘VIF’)를 통해 변수 간 다중공선성 여부(VIF ≥ 5 일 경우 다중공선성 가능성 있음, Shrestha, 2020)를 확인했다. 연구분석을 위한 통계 프로그램은 Mplus 8.4과 SPSS 27.0을 활용하였다.

IV. 연구 결과

1. 간부 스트레스 유형 분류

KMO와 Bartlett의 구형성 검정을 실시한 결과, KMO는 .925로 매우 높은 수준이었으며(Howard, 2016), Bartlett 구형성 검정결과도 $\chi^2(435) = 18051.65, p < .001$ 였다. 따라서 본 연구 자료는 요인 분석을 실시하기에 적합한 것으로 나타났다. 스트레스 척도의 요인 수를 결정하기 위해 이순목 등(2016)이 제시한 방법에 따라 먼저 대략적인 요인 수를 판단하기 위해 발견법으로 사용되는 고유값과 평행선 분석을 진행하고, 이어서 타당한 요인의 수를 결정하기 위해 모델적합도를 이용한 추론적 방식과 측정 오차 간 상관의 허용되는 ESEM 방식을 이용하여 분석하였다. EFA를 이용하여 고유값 확인 결과 1이 넘는 요인의 수는 6개로 나타났으며, 평행선 분석에서는 요인의 수가 4개가 적절한 것으로 나타났다. 이에 따라, Mplus 8.4를 이용하여 4 ~ 6요인 모형에 대한 EFA를 실시하였다. <표 2>에 제시된 바와 같이 요인의 수가 증가함에 따라 모델적합도 지수가 증가하였으며 비록 Vandenberg과 Lance(2000)가 제시한 TLI의 적합도 기준 .9에는 미치지 못했지만, 요인 구조 및 해석 가능성 면에서 6요인 모형이 가장 적합한 것으로 나타났다.

〈표 2〉 EFA와 ESEM 분석 결과($N=500$)

구분		χ^2	df	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
EFA (30개 문항)	4요인	1282.24***	321	0.877	0.833	0.077	0.041
	5요인	1041.71***	295	0.904	0.859	0.071	0.035
	6요인	853.10***	270	0.925	0.880	0.066	0.030
6요인 ESEM (28개 문항)	기본모형	686.48***	225	0.937	0.894	0.064	0.027
	수정모형	616.99***	224	0.946	0.909	0.059	0.025

참고. *** $p < .001$.

요인을 의미 있게 해석하기 위해서는 일반적으로 .30 이상의 요인 부하량이 있어야 함을 고려하여 6요인 모형에서 요인 부하량이 .30 이하인 26번과 27번 문항을 제거한 이후 28개 문항에 대해 부분제약 목표회전을 적용한 ESEM을 실시하였다(기본모형). <표 2>에서 보는 바와 같이, 모델적합도는 전반적으로 향상되었으나 여전히 TLI는 적합한 기준에 미치지 못했다. 이에 유사한 의미를 내포하고 있는 문항들이 있을 가능성을 고려하여 M.I.가 40 이상이 되는 문항(정현희 등, 2022)을 확인한 결과, 4번 문항 ‘위험한 업무수행’과 5번 문항 ‘업무에 대한 체력적 부담’의 M.I.가 67.30으로 높게 나타났다. 군 특성상 위험한 업무 수행(예: 수색, 매복, 강도 높은 군사훈련 등)은 신체적인 체력부담을 일으킬 가능성이 있음을 고려할 때, 4번과 5번 문항은 서로 밀접한 관련성을 가질 수 있다. 이에 두 문항의 상관 잔차를 허용한 ESEM을 실시한 결과, <표 2>의 6요인 수정모형에서 보는 바와 같이 모델적합도 지수가 모두 수용 가능한 수준으로 향상되었다.

〈표 3〉 ESEM 결과에 따른 요인 구조 및 요인 부하량(N=500)

구분	문항	요인1	요인2	요인3	요인4	요인5	요인6
업무 스트레스	1	0.910	-0.102	-0.023	-0.016	0.075	-0.020
	2	0.613	0.143	-0.015	0.098	0.008	-0.003
	4	0.300	0.141	0.182	0.110	-0.032	0.109
	5	0.364	0.236	0.019	0.120	-0.033	0.037
조직문화 스트레스	3	0.383	0.576	-0.143	-0.030	0.008	0.011
	6	0.190	0.300	0.063	0.071	0.166	0.005
	8	0.009	0.620	-0.112	0.197	0.023	0.059
	9	0.143	0.328	0.302	-0.078	0.089	-0.033
	10	-0.010	0.828	0.021	-0.060	0.025	0.008
	11	0.007	0.516	0.174	0.190	-0.052	0.043
	12	0.063	0.619	0.161	-0.171	0.068	-0.011
근무환경 스트레스	19	-0.034	0.547	-0.095	0.302	0.057	-0.031
	13	0.098	-0.021	0.488	0.260	-0.067	0.044
	14	0.106	-0.007	0.515	0.045	0.152	0.049
대인관계 스트레스	15	-0.063	0.175	0.514	0.015	0.220	0.013
	7	0.045	0.313	-0.055	0.438	0.079	0.048
	16	-0.012	0.195	-0.032	0.656	0.052	0.015
	17	0.100	-0.117	0.053	0.844	0.015	-0.019
	18	0.023	0.002	0.125	0.549	0.085	-0.029
가족 스트레스	20	0.132	-0.087	0.163	0.495	0.072	0.079
	21	-0.011	-0.126	0.011	0.100	0.675	0.032
	22	0.124	0.002	0.100	-0.039	0.704	-0.027
	23	0.024	0.027	-0.135	-0.006	0.921	0.017
	24	-0.024	0.070	0.002	0.016	0.787	0.016
	25	-0.057	-0.026	0.114	0.043	0.770	-0.003
개인 스트레스	28	-0.054	0.155	0.187	0.025	0.025	0.392
	29	-0.011	0.003	-0.043	-0.042	-0.014	0.944
	30	0.025	-0.106	-0.042	-0.010	0.009	0.908

참고. 요인분석 과정에서 2개 문항(26, 27)은 제거됨.

6요인 수정모형의 ESEM 분석에 따른 최종 요인 구조 및 요인 부하량은 <표 3>에 제시되어 있다(세부 문항 구성은 부록 2 참조). 분석결과에 따르면, 군 간부 스트레스의 유형은 ① 수행하고 있는 임무나 과업에서 비롯되는 ‘업무 스트레스’, ② 보여주기식 문화 및 진급의 불안정 등 군 문화에서 비롯되는 ‘조직문화 스트레

스’, ③ 열악한 근무지 및 처우에서 비롯되는 ‘근무환경 스트레스’, ④ 상관 또는 부하와의 관계적 측면에서 발생하는 ‘대인관계 스트레스’, ⑤ 가족과 떨어져 지내거나 가정 일을 돌보지 못하는 것에서 비롯되는 ‘가족 스트레스’, ⑥ 개인의 문제적 행동에서 기인하는 ‘개인 스트레스’로 분류되었다. 6가지의 스트레스 하위유형의 이변량 상관관계를 확인한 결과 모두 유의한 정적 관련성을 나타냈다($r = .24$ to $.68, p < .001$). 비록 하위유형들 간 상관관계가 다소 높게 나타났지만, 부록 2에서 보는 바와 같이 업무 스트레스는 개인이 수행하는 구체적 과업과 관련된 불편감을 측정하며, 조직문화 스트레스는 개인 과업보다는 진급 및 잦은 업무 변경 등 군 조직문화에서 비롯되는 스트레스에 초점이 맞춰져 있다. 근무환경 스트레스는 주거 및 생활 환경적 측면에서의 심리적 불편감에 중점을 두고 있으며, 대인관계 스트레스는 부대에서 사회적 상호작용을 하는 대상들과의 관계에서 경험하는 심리적 긴장감을 측정한다. 한편 가족 스트레스는 군 내부적 요인이기보다는 군 직장 생활로 인해 파생되어 발생하는 군 외부적 스트레스로서 가족 관계에서 경험하는 실제적·심리적 어려움을 측정하며, 개인 스트레스는 부대적 측면보다는 사생활 측면에서의 스트레스를 측정하는 데 중점을 두고 있다.

2. 계급별 스트레스 수준 차이 및 스트레스 유형과 연구 변수와의 관련성

<표 4>에서 보는 바와 같이 ESEM 분석결과 분류된 6가지 유형의 스트레스 수준이 계급에 따라 차이가 나타나는지 살펴보았다. 평균 점수를 기준으로 살펴보면 스트레스 수준은 전반적으로 영관장교(소·중령) 집단이 가장 높았으며, 이어서 대위, 상·원사 집단 순으로 높았다. 하사, 중사, 소·중위는 유사한 수준이었으며, 준위 집단이 가장 낮은 스트레스 수준을 보였다. ANOVA를 통한 집단 비교 결과, 영관장교 집단이 대체로 초급간부(하사, 중사, 소·중위)보다 유의하게 높은 수준의 스트레스를 나타냈으며, 업무 스트레스와 근무환경 스트레스, 개인 스트레스는 사후 검증(Scheffé test)에서 유의한 차이를 나타내는 집단이 없었다.

<표 4> 계급별 스트레스 수준 차이(N=500)

구분	하사 (1) M(SD)	중사 (2) M(SD)	상·원사 (3) M(SD)	준위 (4) M(SD)	소·중위 (5) M(SD)	대위 (6) M(SD)	소·중령 (7) M(SD)	집단 비교 (ANOVA)	Scheffé Test
스트레스 전체	38.58 (20.75)	38.24 (21.38)	41.83 (19.34)	16.33 (4.16)	37.26 (21.13)	46.02 (20.20)	57.78 (19.98)	$F(6,493)=4.82^{***}$	$7>1,2,5$
업무	5.68 (3.56)	5.35 (3.87)	5.25 (3.48)	2.33 (.57)	5.08 (3.52)	5.74 (3.12)	7.83 (3.73)	$F(6,493)=2.37^*$	-
조직문화	16.10 (7.99)	16.20 (8.21)	16.73 (7.43)	7.00 (3.61)	13.55 (7.08)	18.31 (7.16)	20.57 (7.18)	$F(6,493)=3.84^{**}$	$7>5$
근무환경	4.11 (3.16)	3.95 (3.26)	4.73 (3.10)	2.00 (1.00)	4.38 (3.46)	4.63 (3.56)	5.83 (3.28)	$F(6,493)=1.80$	-
대인관계	5.01 (4.75)	4.61 (4.43)	6.45 (4.23)	2.67 (2.31)	4.76 (4.41)	6.07 (4.03)	9.87 (5.47)	$F(6,493)=6.27^{***}$	$7>1,2,5$
가족	6.99 (5.77)	7.31 (5.92)	7.94 (5.44)	2.00 (2.65)	8.66 (6.48)	10.46 (6.21)	12.65 (4.65)	$F(6,493)=5.58^{***}$	$6>1$ $7>1,2$
개인	.68 (1.15)	.81 (1.39)	.73 (1.15)	.33 (.57)	.83 (1.39)	.80 (1.28)	1.04 (1.61)	$F(6,493)=.38$	-

참고. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

스트레스 유형과 연구 변수들의 상관관계는 <표 5>에 제시되어 있다(기술통계 결과는 부록 3 참조). 먼저 인구통계학적 측면에서 나이가 많을수록 근무환경, 대인관계 스트레스 수준이 증가했으며, 이와 유사하게 남군보다 여군이 근무환경과 대인관계에서 더 높은 스트레스 수준을 보였다. 교육수준이 높을수록 가족 스트레스 수준이 높았으며, 배우자가 있는 간부의 경우 대인관계 스트레스 수준이 높게 나타났다. 한편 중견 간부일수록 업무와 개인 스트레스를 제외한 나머지 스트레스 유형에서 더 높은 스트레스를 보고했다($r = .11$ to $.23$, $p < .05$).

스트레스 유형들은 전반적으로 자살 행동 및 우울증과 유의한 정적 상관관계를 나타냈다($r = .15$ to $.42$, $p < .01$). 즉 군 스트레스 수준이 높을수록 자살 행동 경향성과 우울증의 수준은 높게 나타났는데, 스트레스 유형 중 대인관계 스트레스가 높은 상관관계를 보였다. 단, 근무환경과 개인 스트레스는 자살 행동과 유의한 관련성을 나타내지 않았다. 자살 행동 및 정신건강의 보호요인이 될 수 있는 감사성향과 사회적 지지는 스트레스 유형들과 모두 유의한 부적 관련성을 보였다($r =$

-.18 to -.35, $p < .001$). 마지막으로, 사회적 바람직성이 높을수록 스트레스 수준은 낮았다. 즉 자신을 긍정적으로 보이려는 성향이 높을수록 스트레스 수준은 낮게 보고하였다.

〈표 5〉 스트레스와 연구변수 간 상관관계^{a)}

구분	스트레스 총점	스트레스 하위유형					
		업무	조직 환경	근무 환경	대인 관계	가족	개인
나이	.12**	.05	.08	.11*	.19***	.08	.04
성별 ^{b)}	.06	.04	.01	.13*	.09*	.06	.08
교육수준	.04	.03	.01	.00	.06	.09*	-.05
결혼상태 ^{c)}	.08	.03	.06	.09	.11*	.08	-.05
신분 ^{d)}	.15**	.02	.11*	.11*	.23***	.14***	.02
자살 행동	.20***	.16***	.20***	.08	.20***	.15***	.01
우울증	.44***	.37***	.39***	.25***	.42***	.33***	.15***
감사성향	-.31***	-.25***	-.25***	-.22***	-.28***	-.22***	-.19***
사회적 지지	-.29***	-.18***	-.22***	-.19***	-.35***	-.19***	-.20***
사회적 바람직성	-.28***	-.15**	-.24***	-.18***	-.21***	-.30***	-.08

참고. a) 성별, 교육수준, 결혼상태, 신분은 Spearman correlation, 연속 변수는 Pearson correlation 제시($N=500$); b) 남자(1), 여자(2); c) 독신(1), 기혼/사실혼(2); d) 초급간부(1), 중견간부(2).
* $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

〈표 5〉에 제시하지는 않았으나, 감사성향 및 사회적 지지 수준이 높을수록 자살 행동과 우울증 수준은 유의하게 낮았으며($r = -.21$ to $-.35$, $p < .001$), 이와 유사하게 사회적 바람직성이 높을수록 자살 행동 및 우울증 수준은 낮게 나타났다($r = -.20$ to $-.25$, $p < .001$). 인구통계학적 변수 중 여성일수록 자살 행동과 우울증이 높게 나타났고($r = .10$ to $.11$, $p < .05$), 나이와 결혼상태는 각각 우울증과만 유의한 관련성($r = -.09$ to $-.10$, $p < .05$)을 보였다. 즉 나이가 많고 배우자가 있는 간부일수록 우울 수준은 낮았다. 신분과 교육수준은 자살 행동 및 우울증과 유의한 상관관계가 없었다.

요약하면, 군 간부들의 자살 행동과 우울증에 스트레스와 보호요인(감사성향, 사회적 지지)은 전반적으로 유의한 관련성을 나타냈고, 스트레스 하위유형 중 업무와 개인 스트레스를 제외하고 나머지 스트레스 유형에서 신분별(초급간부 vs. 중견

간부)로 차이가 나타났다. 이에 6가지 스트레스 하위유형과 보호요인이 군 간부들의 자살 행동과 정신건강에 미치는 차별적인 영향력을 검증하기 위해 위계적 회귀분석을 실시했으며, 사회적 바람직성과 더불어 인구통계학적 변수 중 자살 행동 또는 우울증과 유의한 관련성을 나타낸 나이와 성별, 결혼상태는 통제변수로 사용하였다.

3. 스트레스 유형이 자살 행동, 우울증에 미치는 차별적 영향

스트레스 세부 유형의 차별적 영향을 검증하기에 앞서 선행분석을 통해 통합적 관점에서 스트레스 전체 점수를 예측변수로 투입하고 통제변인(나이, 성별, 결혼상태) 및 보호변인(감사성향, 사회적 지지)을 포함한 다중 회귀분석을 실시하였다(부록 4). 그 결과 스트레스는 자살 행동($\beta = .13, p < .01$)과 우울증($\beta = .36, p < .001$)에 모두 유의한 영향력을 나타냈다. 이어서 초급간부와 중견간부로 구분하여 동일한 다중 회귀분석을 실시한 결과, 스트레스 총점은 중견간부의 자살 행동($\beta = .20, p < .01$)에 유의한 영향을 나타냈지만, 초급간부 집단에서는 유의한 차별적 관련성이 없었다. 한편 우울증의 경우 두 집단(초급간부: $\beta = .38, p < .001$, 중견간부: $\beta = .36, p < .001$)에서 모두 유의한 영향력을 나타냈다. 이러한 결과를 바탕으로, 세부 스트레스 유형별로 자살 행동과 우울증에 미치는 차별적인 영향력을 검증하기 위해 위계적 회귀분석을 진행했다.

먼저 자살 행동은 <표 6>에 제시된 바와 같이, 1단계 신분별 분석에서 초급간부의 경우 대인관계 스트레스가 자살 행동에 유의한 영향력을 나타냈으나($\beta = .17, p < .05$), 중견간부는 차별적 영향력을 나타내는 스트레스 유형이 없었다. 보호요인이 투입된 2단계 분석(전체집단) 결과 감사성향과 사회적 지지는 각각 자살 행동 수준에 유의한 관련성을 나타냈는데, 집단별로 그 영향력이 달랐다. 즉 초급간부는 사회적 지지가, 중견간부는 감사성향이 각각 유의하게 자살 행동 위험성을 감소시켰다. 한편 통제변수로 투입된 변수 중 성별은 1단계와 2단계 분석에서 모두 유의한 영향력을 나타냈는데, 신분별 분석결과 중견간부 집단에서 유의한 영향력이 나타났다. 즉 중견간부의 남성보다는 여성이 자살 행동의 위험성이 더 높았다. 1단계 및

2단계 회귀분석에서 각각 모델적합도는 유의하게 나타났으며, 전체집단 기준으로 2단계 회귀분석에서 투입된 독립변수들의 설명량은 총 12%였다. 각 회귀분석에서 VIF 확인 결과 모두 5 이하로 나타나 독립변수들의 다중공선성 문제는 없었다.

〈표 6〉 스트레스 유형이 자살 행동에 미치는 영향

구분	자살 행동					
	전체(N=500)		초급간부(N=300)		중견간부(N=200)	
	B(SE)	β	B(SE)	β	B(SE)	β
1단계						
통제변수						
나이	-.00(.01)	.00	-.01(.03)	-.02	.01(.02)	.04
성별	.52(.21)	.11*	.36(.27)	.08	.84(.36)	.17*
결혼상태	-.07(.20)	-.02	.10(.28)	.02	-.16(.29)	-.05
사회적 바람직성	-.12(.04)	-.15**	-.15(.05)	-.19**	-.05(.06)	-.06
스트레스						
업무	.01(.03)	.03	-.01(.04)	-.03	.05(.05)	.10
조직문화	.02(.01)	.11	.02(.02)	.10	.03(.03)	.15
근무환경	-.04(.03)	-.08	-.07(.04)	-.13	-.01(.04)	-.02
대인관계	.04(.02)	.12	.06(.03)	.17*	.01(.04)	.02
가족	.01(.02)	.04	.01(.02)	.04	.02(.03)	.06
개인	-.09(.06)	-.07	-.10(.07)	-.08	-.08(.10)	-.06
R ²	.09, F(10,489)=4.83***		.09, F(10,289)=3.01**		.12, F(10,189)=2.56**	
2단계						
통제변수						
나이	-.01(.01)	-.02	-.02(.03)	-.05	.01(.02)	.02
성별	.49(.21)	.10*	.32(.27)	.07	.80(.35)	.16*
결혼상태	.09(.20)	.03	.29(.28)	.07	.04(.29)	.01
사회적 바람직성	-.12(.04)	-.14**	-.14(.05)	-.17**	-.05(.06)	-.07
스트레스						
업무	.01(.03)	.02	-.02(.04)	-.04	.06(.05)	.13
조직문화	.02(.01)	.11	.02(.02)	.11	.03(.03)	.14
근무환경	-.05(.03)	-.09	-.07(.04)	-.14	-.02(.04)	-.03
대인관계	.02(.02)	.06	.04(.03)	.11	-.02(.04)	-.05
가족	.01(.02)	.03	.01(.02)	.05	.01(.03)	.03
개인	-.12(.06)	-.09	-.12(.07)	-.10	-.10(.09)	-.08
보호요인						
감사성향	-.03(.01)	-.11*	-.01(.02)	-.03	-.07(.02)	-.28**
사회적 지지	-.02(.01)	-.12*	-.03(.01)	-.20**	.01(.01)	.05
R ²	.12, F(12,487)=5.65***		.13, F(12,287)=3.66***		.17, F(12,187)=3.23***	
ΔR^2	.03, F(2,487)=8.97***		.04, F(2,287)=6.33**		.05, F(2,187)=5.91**	

참고 * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

<표 7>에 제시된 바와 같이 우울증의 경우, 1단계 분석에서 업무 스트레스와 대인관계 스트레스가 각각 유의한 영향력을 나타냈다. 초급간부 집단에서는 대인관계 스트레스만 유의한 영향력이 있었으며($\beta = .25, p < .01$), 중견간부 대상 회귀분석에서는 업무 스트레스와 대인관계 스트레스가 차별적인 영향력을 나타냈다($\beta = .18 \text{ to } .32, p < .05$). 감사성향과 사회적 지지가 포함된 2단계 분석에서도 스트레스의 영향력은 동일한 패턴을 보였다. 즉 전체집단과 중견간부 집단에서는 다른 유형의 스트레스 영향력을 제외하고도 업무 스트레스와 대인관계 스트레스가 각각 차별적인 영향력을 나타냈으며, 초급간부 집단에서는 대인관계 스트레스만 유의한 관련성을 보였다($\beta = .13 \text{ to } .23, p < .05$).

2단계 분석(전체집단)에서 감사성향과 사회적 지지는 각각 우울증을 감소시키는 것으로 나타났으며, 신분별 분석에서 초급간부의 경우 감사성향과 사회적 지지 모두 우울증과 유의한 관련성을 나타냈지만, 중견간부 집단에서는 감사성향만 우울증 감소와 유의한 관련성을 보였다. 보호요인이 투입되었을 때 스트레스 유형 중 업무 스트레스의 영향력은 크게 변하지 않았으나 대인관계 스트레스의 영향력이 다소 감소하였다($\beta : .26 \rightarrow .19$). 한편 자살 행동을 예측하는 회귀분석 결과와 유사하게 인구통계학적 변수 중 성별은 중견간부 집단에서 우울증과 유의한 관련성을 보였다. 즉 스트레스와 보호요인(감사성향, 사회적 지지)의 영향력을 통제한 이후에도 남성보다 여성의 우울증 수준이 더 높게 나타났다. 나이는 우울증과 부적 관련성을 보였는데, 이는 스트레스 변수들의 영향력이 없을 경우 연령이 낮을수록 우울증 수준이 높을 수 있음을 시사한다. 그리고 결혼상태는 다중 회귀분석에서 우울증과 유의한 관련성이 없었다.

1단계 회귀분석 및 2단계 회귀분석 시 모델적합도는 모두 유의하게 나타났으며, 전체집단 기준으로 2단계 회귀분석에서 투입된 독립변수들의 설명량은 총 31%였다. 각 회귀분석에서 VIF를 확인한 결과 모두 5 이하로 나타나 독립변수들의 다중공선성 문제는 없었다.

〈표 7〉 스트레스 유형이 우울증에 미치는 영향

구분	우울증						
	전체(N=500)		초급간부(N=300)		중견간부(N=200)		
	B(SE)	β	B(SE)	β	B(SE)	β	
1단계							
통제변수	나이	-.07(.03)	-.10*	-.12(.08)	-.08	-.01(.05)	-.01
	성별	.88(.54)	.06	.14(.73)	.01	2.24(.83)	.17**
	결혼상태	-.46(.50)	-.05	.08(.76)	.01	-.60(.66)	-.06
	사회적 바람직성	-.29(.09)	-.13**	-.37(.13)	-.16**	-.10(.15)	-.05
스트레스	업무	.18(.07)	.14*	.13(.09)	.10	.22(.11)	.18*
	조직문화	.04(.04)	.08	.07(.05)	.12	-.00(.06)	-.01
	근무환경	-.07(.07)	-.05	-.05(.11)	-.03	-.12(.10)	-.10
	대인관계	.23(.06)	.26***	.27(.08)	.25**	.30(.09)	.32***
	가족	.07(.04)	.09	.06(.06)	.08	.10(.06)	.14
	개인	.02(.15)	.01	-.01(.20)	-.00	.05(.22)	.02
	R^2	.26,		.25,		.31,	
		$F(10,489)=17.12***$		$F(10,289)=9.65***$		$F(10,189)=8.52***$	
2단계							
통제변수	나이	-.08(.03)	-.13*	-.15(.08)	-.10	-.02(.04)	-.03
	성별	.75(.53)	.06	.02(.70)	.00	2.05(.80)	.15**
	결혼상태	.10(.49)	.01	.73(.75)	.06	-.07(.66)	-.01
	사회적 바람직성	-.28(.09)	-.12**	-.34(.12)	-.14**	-.12(.14)	-.06
스트레스	업무	.16(.07)	.13*	.10(.09)	.07	.25(.10)	.21*
	조직문화	.04(.04)	.07	.07(.05)	.12	-.01(.06)	-.02
	근무환경	-.09(.07)	-.06	-.07(.10)	-.05	-.13(.10)	-.10
	대인관계	.19(.06)	.19**	.20(.08)	.19**	.21(.09)	.23*
	가족	.06(.04)	.08	.07(.06)	.09	.08(.06)	.11
	개인	-.07(.15)	-.02	-.10(.20)	-.03	-.05(.21)	-.01
	보호요인						
감사성향	-.11(.03)	-.15**	-.10(.04)	-.13*	-.12(.05)	-.20*	
사회적 지지	-.06(.02)	-.14**	-.07(.03)	-.17**	-.04(.03)	-.10	
R^2	.31,		.31,		.36,		
	$F(12,487)=18.48***$		$F(12,287)=9.65***$		$F(12,187)=8.93***$		
ΔR^2	.05,		.06,		.05,		
	$F(2,487)=18.99***$		$F(2,287)=10.50***$		$F(2,187)=7.90**$		

참고 * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

V. 논의

간부들의 정신건강은 개인의 웰빙 측면에서 중요한 요소일 뿐만 아니라 인구 감소에 따라 향후 간부 중심으로 군이 개편될 수 있음을 고려할 때(최병욱·임유신, 2015) 전투력에도 주요한 영향을 미칠 수 있다. 이에 본 연구는 우리나라 육군 간부들의 스트레스 유형을 분류하고, 자살 행동 및 우울증과의 관련성을 검증하는데 목적을 두고 진행되었다. 연구 결과를 요약하면, ESEM을 통해 간부들의 스트레스는 6가지 유형(업무, 조직문화, 근무환경, 대인관계, 가족, 개인)으로 분류되었으며, 계급별 비교에서 영관장교(소·중령)들의 스트레스 수준이 가장 높게 나타났다. 전반적으로 스트레스는 자살 행동 및 우울증과 유의한 상관관계를 나타냈으며, 인구통계학적 변인과 보호요인(감사성향, 사회적 지지)의 영향력을 제외한 이후에도 자살 행동과 우울증에 유의한 영향력을 나타냈다(부록 4). 스트레스 세부 유형별 차별적인 영향력을 살펴보기 위해 통제변인과 보호요인의 영향력을 포함하여 신분별(초급간부, 중견간부)로 위계적 회귀분석을 실시한 결과, 초급간부의 경우 대인관계 스트레스가 자살 행동과 우울증에 유의한 관련성을 나타냈으며, 중견간부의 경우에는 업무 스트레스와 대인관계 스트레스가 우울증에 유의한 영향력을 나타냈다.

먼저 계급별 및 신분별 스트레스 수준(평균 점수)을 비교해 보면 초급간부 계층보다 중견간부 계층에서 스트레스 수준이 더 높게 나타났다. 최근 5년간 정신질환으로 인한 진료 건수에서는 중견간부 계층인 상사가 가장 많았던 점을 고려하면(신은진, 2023), 초급간부뿐만 아니라 장기복무 중인 간부들의 스트레스에도 관심을 가져야 함을 보여준다. 특히, 영관장교의 경우 통계적 검증에서 스트레스 수준이 가장 높았는데, 이들은 심리적인 긴장감을 해결하기 위해 정신건강 서비스를 이용할 경우 인사평가나 진급 등에서 불리하게 평가받을 것을 염려하여 외부 도움 없이 스트레스를 견디며 생활하는 것으로 추측된다. 물론 중견간부들은 대부분 장기 복무자로서 이미 신체적·심리적으로 건강한 선별된 자원이기에 스트레스를 경험해도 자살 행동과 같은 부적응적 결과를 상대적으로 낮게 나타낼 수도 있으나(예: healthy

warrior effect, Wilson et al., 2009), 스트레스와 우울증의 유의한 관련성을 고려하여 스트레스로 인한 소진이 발생하지 않도록 관심을 기울여야 할 것이다. 한편 통계적 검증에서 업무와 근무환경, 개인 스트레스는 계급별 비교(Scheffé test)에서 유의한 차이가 없었다. 다른 계급에 비해 영관장교 집단이 비교적 높은 수준의 스트레스를, 준위 집단이 가장 낮은 수준의 스트레스를 보고했지만, 통계적 검증에서 유의성이 나타나지 않은 이유는 두 집단의 샘플 인원이 적어 발생한 결과일 수도 있고, 세부 스트레스 문항에서 상반된 응답으로 인해 나타난 결과일 수도 있다. 예를 들어, 업무 스트레스 중 많은 업무량으로 인한 스트레스(1번 문항)는 소령 등 영관장교들이 다른 계급에 비해 높게 보고할 가능성이 있으나, 위험한 임무 수행으로 인한 스트레스(4번)는 초급간부가 더 높게 보고했을 가능성이 있다. 따라서 이러한 세부 문항들이 통합된 업무 스트레스 유형에서 집단 간 유의한 차이가 발생하지 않을 수 있다. 추후 연구에서는 각 집단별로 충분한 샘플 인원을 확보하여 각 세부 문항별 스트레스의 차이를 분석할 필요가 있다.

다음으로, 스트레스 하위유형 중 대인관계 스트레스가 자살 행동과 우울증의 주요한 예측 변인이 될 수 있음을 주목할 필요가 있다. 지방공무원을 대상으로 한 연구에서도 직무특성이나 조직 분위기보다 대인관계에서의 스트레스가 우울 증상과 가장 높은 관련성을 나타냈는데(박숙영·박소연, 2018), 본 연구 결과도 수직적인 대인관계 및 상·하급자와의 원만하지 않은 관계에서 비롯되는 스트레스가 자살 행동 및 정신건강에 유의한 차별적 영향력을 나타냈다. 선행연구에서는 주로 군 간부들의 직무수행과 관련된 역할 또는 환경적 측면의 스트레스가 자살 행동이나 정신건강에 미치는 영향을 밝혀왔는데(권명훈·이재은, 2023; 박승일·이동귀, 2014; 허태선 등, 2022), 본 연구는 조직문화나 근무환경, 업무 자체로 인한 스트레스보다 대인관계에서 발생하는 스트레스가 간부들의 정신건강에 더 강한 관련성을 나타낼 수 있음을 보여주었다.

1단계 회귀분석에서 다른 스트레스 요인들의 영향력과 독립적으로 업무 스트레스는 중견간부의 우울증에 유의한 영향력을 나타냈다. 이는 직무수행에 대한 시간적인 압박이나 많은 업무량, 책임감 상승 등을 포함하는 직무요구가 심리적 소진과

유의한 정적 상관관계를 나타냈던 선행연구(권소영, 2016)와 유사한 결과이다. 군 간부들은 육체적 임무뿐만 아니라 행정적 업무를 병행하여 수행할 수 있고, 병력관리나 부대관리 관련 임무가 부가될 경우 과도한 업무로 인해 심리적·육체적 피로감과 우울감을 경험할 수 있다.

보호요인이 투입된 2단계 회귀분석 결과에서는 개인 내적 자원(감사성향)과 사회적 관계에서의 자원(사회적 지지)이 스트레스의 부정적 영향력을 감소시키고 정신건강에 긍정적 영향력을 나타냄을 보여주었다. 정서적 연결망 이론(Bower, 1981)에 의하면, 즐거운 사건을 생각하는 능력은 스트레스 사건을 이겨낼 때 도움을 준다. 일반인을 대상으로 한 선행연구(최지영·이민규, 2016; Emmons, 2007)와 유사하게, 본 연구에서도 삶에서 감사할 것을 발견하거나 타인에게 고마움을 느낄수록 스트레스의 영향력에도 불구하고 중견간부들의 자살 행동 및 우울증 수준은 유의하게 감소하였다. 사회적 지지는 스트레스가 군인들의 정신건강 문제에 미치는 영향력을 완충하는 요인으로 밝혀져 왔는데(설정훈·박수현, 2015), 본 연구에 따르면 초급간부 집단에서 사회적 지지의 긍정적 영향력이 더 두드러지게 나타났다. 따라서 삶에서 감사함을 경험하는 훈련(예: 김별남·이인혜, 2009)이나 사회적 지지가 제공되는 환경을 조성하는 것은 군 간부들의 정신건강 증진에 도움이 될 수 있다.

본 연구의 주목할만한 또 다른 결과는 남성 군인과 비교하여 여성 군인(특히, 중견간부)의 정신건강이 더 부정적일 수 있다는 것이다. 군 내에 여성의 비율이 점차 확대되고 있으나, 이들의 정신건강에 대해서는 아직 많은 연구가 진행되지 않았다. 우리나라에서는 여군의 직무 스트레스와 건강상태의 관련성(김유경 등, 2017), 일-가정에서의 스트레스(손귀현 등, 2018) 등과 관련하여 일부 선행연구가 진행되었으나, 여군의 정신건강에 영향을 미치는 위험요인과 보호요인을 검증한 포괄적인 연구는 아직 부족하다. 따라서 향후 연구에서는 여성들의 정신건강을 증진할 수 있는 요인들을 검증할 필요가 있으며, 특히 남군과의 비교에서 비롯되는 편견(Kim, et al., 2011)이 심리적 안녕감이나 주관적 웰빙에 미치는 영향을 검증하는 것도 의미 있을 것이다.

본 연구의 한계점과 향후 연구에 대한 제언은 다음과 같다. 먼저 본 연구의 자료는

자기 보고식 설문으로 측정되어 간부들의 응답이 긍정 편향되었을 가능성이 있다. 비록 연구 대상자들이 무기명으로 설문에 참여하고, 통제변수로 사회적 바람직성을 포함하여 분석함으로써 설문 응답에 대한 불성실성을 통제하려고 노력했으나 설문에 응답하는 과정에서 부정적인 측면을 측정하는 설문 문항(예: 자살 행동, 우울증 등)에서 부정적 응답을 회피했을 가능성이 있다. 반면 사회적 지지나 감사성향과 같은 질문에서는 자신을 우호적으로 보이기 위해 더 호의적으로 평가했을 가능성을 배제하기 어렵다.

둘째, 선행연구에서 활용된 육군 간부 스트레스 문항을 수정 및 보완하여 28개 문항으로 구성된 스트레스 문항을 재정립하고, ESEM을 통해 스트레스 하위유형을 분류했으나, 향후 육군뿐 아니라 해군이나 공군 간부들의 스트레스를 측정하기 위한 척도를 체계적으로 개발하고 타당화하기 위해서는 스트레스 문항에 대해 야전 및 실무에서 근무하는 해당 부대 간부들의 의견수렴을 진행할 필요가 있다. 또한, 신뢰도와 타당도 검증을 통한 과학적 분석 절차도 병행해야 할 것이다.

셋째, 본 연구의 자료는 횡단적으로 수집되었기에 변수 간의 인과관계 방향성을 특정하기 어렵다. 비록 선행연구에서 스트레스 요인, 감사성향, 사회적 지지 등은 자살 행동 또는 우울증을 예측하는 위험요인 및 보호요인으로 사용되었지만(설정훈·박수현, 2015; 최지영·이민규, 2016; Baumeister, 1990; Emmons, 2007), 우울 증상이 높을수록 스트레스가 더 많다고 지각하거나 사회적 지지를 낮게 평가할 가능성도 있기 때문이다. 따라서 추후 연구에서는 종단 데이터를 활용하여 군 간부들의 자살 행동 및 우울증에 영향을 미치는 예측변수들을 규명할 필요가 있다.

넷째, 본 연구에서 투입된 예측변수들이 자살 행동과 우울증에 미치는 전체 영향력은 각각 12%, 31%였다. 이는 자살 행동 및 우울증에 영향을 미치는 변수들이 아직 많이 남아 있음을 의미한다. 선행연구에 따르면 외상 경험, 수면시간, 회복탄력성 등도 주요한 예측변수로 밝혀졌는데(이진욱·남진영, 2022; Watters et al., 2023), 추후 연구에서는 외상 경험과 같은 다른 유형의 스트레스 및 건강 관련 행동, 개인 내적 및 사회적 자원 변수들을 포함하여 자살 행동과 우울증을 예측하는 요인들을 검증할 필요가 있다.

이러한 연구의 한계점에도 불구하고, 본 연구는 세부적 관점에서 군 간부들이 경험하는 스트레스 유형을 분류하고, 각 스트레스 유형이 자살 행동 및 우울증에 영향을 미치는 차별적인 영향력을 신분별(초급간부, 중견간부)로 검증했다는 점에서 학문적 의의가 있다. 더불어 군 간부들의 스트레스와 우울증 등을 해소하는데 도움을 주고자 최근 국방부에서는 2020년부터 민간 심리상담지원 프로그램을 운영하고 있는데(강국진, 2023), 본 연구의 결과는 위와 같은 군 간부 대상 상담 프로그램이나 관련 정책을 추진할 때 필요한 실용적 자료로도 사용될 수 있을 것이다.

논문 접수: 2024년 9월 28일
논문 수정: 2025년 4월 2일
게재 확정: 2025년 4월 9일

참고문헌

- 강국진. (2023. 1. 15.). “軍 ‘극단적 선택’ 병사보다 간부가 더 많아...비대면 심리상담에서 해법 찾는다.” 『서울신문』. <https://www.seoul.co.kr/news/politics/2023/01/15/20230115500077>.
- 강성록·고재원·김용주. (2012). “군내 스트레스 분석을 통한 스트레스 진단 척도 개발 연구.” 『한국심리학회지: 일반』, 제31권 제2호. pp. 345-367.
- 구승신·윤호순. (2016). “군 간부의 상담능력향상을 위한 상담교육 개선방안.” 『한국콘텐츠학회논문지』, 제16권 제7호. pp. 730-739.
- 국방부. (2023). 2023 국방통계연보 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr/data/15050545/fileData.do>). (검색일: 2024. 9. 5.).
- 국방부. (2024). 「병영생활전문상담관 운영에 관한 훈령」.
- 국립정신건강센터. (2020). 『정신과적 응급상황에서의 위험평가 안내』.
- 권명훈·이재은. (2023). “군 간부의 직무 스트레스가 자살생각에 미치는 영향: 심리적 안녕감을 통한 자기자비의 매개된 조절효과.” 『한국콘텐츠학회논문지』, 제23권 제3호. pp. 624-636.
- 권선중·김교현·이홍석. (2006). “한국판 감사 성향 척도(K-GQ-6) 의 신뢰도 및 타당도.” 『한국심리학회지: 건강』, 제11권 제1호. pp. 177-190.
- 권소영. (2016). “군 간부의 직무스트레스가 소진에 미치는 영향 : 집단효능감을 통한 자기 효능감의 매개된 조절효과.” 상지대학교 박사학위 논문.
- 권승재. (2001). “병영스트레스가 군 범죄행동에 미치는 영향에 관한 연구.” 동국대학교 석사학위 논문.
- 권희경·이현주. (2020). “사회적 바람직성 편향이 자기보고식 측정에 미치는 영향.” 『한국청소년연구』, 제31권 제4호. pp. 251-282.
- 김별남·이인혜. (2009). “감사 지각이 자기초점주의와 우울에 미치는 영향.” 『한국심리학회지: 건강』, 제14권 제2호. pp. 363-382.
- 김영태·이현엽. (2009). “병영생활 전문상담관제도의 효과성 분석 및 발전방안 탐색.” 『국방정책연구』, 제25권 제3호. pp. 177-200.
- 김용석. (2010). “사회적 바람직성 척도의 개발.” 『한국사회복지행정학』, 제12권 제3호. pp. 1-39.
- 김유경·이선미·정선옥·심윤희·노미영. (2017). “함정 근무 여군의 직무 스트레스, 건강증진 행위, 건강상태의 관련성.” 『군진간호연구』, 제35권 제1호. pp. 53-64.

- 김윤희·양명숙·박희룡. (2015). “대학생의 생활스트레스와 자살생각 간의 관계: 정신건강의 매개효과.” 『디지털융복합연구』, 제13권 제11호. pp. 291-301.
- 김재엽·최유일. (2021). “군 간부의 가족갈등이 자살 행동에 미치는 영향-직무스트레스의 매개효과를 중심으로.” 『인적자원관리연구』, 제28권 제1호. pp. 27-43.
- 노지혜·이민규. (2011). “나는 왜 감사해야 하는가?: 스트레스 상황에서 감사가 안녕감에 미치는 영향.” 『한국심리학회지: 임상』, 제30권 제1호. pp. 159-183.
- 박선영·김경미. (2013). “병사의 지각된 스트레스 및 괴롭힘 피해경험과 우울의 관계: 자기 자비의 조절효과.” 『상담학연구』, 제14권 제6호. pp. 3691-3707.
- 박숙영·박소연. (2018). “지방공무원의 직무스트레스가 직무만족도에 미치는 영향: 우울증상 매개효과.” 『지방정부연구』, 제21권 제4호. pp. 123-142.
- 박승일·이동귀. (2014). “군(軍) 초급간부의 직무만족, 직무스트레스, 분노표현, 우울, 무망감이 자살생각에 미치는 영향.” 『한국심리학회지: 상담 및 심리치료』, 제26권 제2호. pp. 545-571.
- 박승진·최혜라·최지혜·김건우·홍진표. (2010). “한글판 우울증 선별도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)의 신뢰도와 타당도.” 『대한불안학회지』, 제6권 제2호. pp. 119-124.
- 박일·김민순·고영진. (2013). “직업군인이 군 생활을 힘들어 하는 이유는?: 장교들의 인식 유형과 심리적 특성.” 『한국심리학회지: 산업 및 조직』, 제26권 제4호. pp. 625-651.
- 박찬희. (2020). “CIPP 모형을 활용한 그린캠프 평가지표 연구.” 『한국콘텐츠학회논문지』, 제20권 제3호. pp. 491-505.
- 문호석·강성록. (2016). “육군 간부의 스트레스에 대한 평가 및 원인 연구.” 『한국군사학논집』, 제72권 제2호. pp. 29-55.
- 설정훈·박수현. (2015). “해군 장병의 스트레스와 인지적 정서조절전략이 정신건강 문제에 미치는 영향: 지각된 사회적 지지의 조절된 매개효과.” 『한국심리학회지: 임상』, 제34권. pp. 553-578.
- 손귀현·손영우·정은경. (2018). “여군들의 일-가정 갈등과 군 사기와의 관계: 직무소진의 매개효과와 유리천장 인식의 조절효과.” 『한국심리학회지: 산업 및 조직』, 제31권 제1호. pp. 175-194.
- 신은진. (2023. 10. 10). “마음의 병 앓는 장병들... 군인 정신질환 진료 매년 4만6,000건.” 『헬스조선』. https://health.chosun.com/site/data/html_dir/2023/10/10/2023101001281.html
- 유태현. (2004). “병영 스트레스가 군 범죄 행동에 미치는 영향에 관한 연구.” 국방대학교

석사학위 논문.

- 이순목·윤창영·이민형·정선호. (2016). “탐색적 요인분석: 어떻게 달라지나?.” 『한국심리학회지: 일반』, 제35권 제1호. pp. 217-255.
- 이영선. (2014). “우울증과 자아정체감이 군인의 자살생각에 미치는 영향: 군인 교육생 대상으로.” 『교육연구』, 제22권. pp. 57-80.
- 이자영. (2015). “부사관의 역할스트레스가 소진, 우울, 이직의도에 미치는 영향.” 『한국콘텐츠학회논문지』, 제15권 제4호. pp. 303-315.
- 이지은·김정호·김미리혜. (2016). “감사일지 작성이 우울 성향이 있는 여대생의 우울, 주관적 웰빙, 낙관성 및 인지적 정서조절전략에 미치는 효과.” 『한국심리학회지: 건강』, 제21권 제1호. pp. 19-46.
- 이진욱·남진영. (2022). “근로자의 수면시간과 근무 형태가 우울에 미치는 영향: 연령별 차이.” 『대한보건연구』, 제48권 제4호. pp. 113-131.
- 이현엽. (2022). “베트남전 참전군인의 정신적 웰빙과 관련된 개인적·가족적·사회적 체계 요인.” 『사회융합연구』, 제6권 제1호. pp. 65-79.
- 장기수. (2013). “군 복무부적응자의 그린캠프 참여가 우울증 감소에 미치는 영향.” 동국대학교 석사학위 논문.
- 장재현·이기학. (2013). “외상경험에 의한 심리적 어려움과 회복요인에 대한 개념도 연구: 천안함 피격사건 생존장병을 중심으로.” 『상담학연구』, 제14권 제1호. pp. 1145-1164.
- 전겸구·김교현·이준석. (2000). “개정판 대학생용 생활 스트레스 척도 개발연구.” 『한국심리학회지: 건강』, 제5권 제2호. pp. 316-335.
- 전지경·이종형. (2007). “軍(군) 내 배척병사와 선호병사 및 일반병사의 성격특성 연구-KMPI를 중심으로.” 『상담학연구』, 제8권 제1호. pp. 47-62.
- 정승원. (2016. 10. 06). “군복무 스트레스? 5년간 정신과 진료 장병 6만 명.” 『데일리메디』. https://dailymedi.com/news/news_view.php?wr_id=810947.
- 정신영·이동귀. (2011). “자살 위험 병사들의 심리특성 연구.” 『상담학연구』, 제12권 제3호. pp. 897-914.
- 정신영·이동귀. (2012). “자살시도 병사의 위험 요인과 보호 요인에 관한 개념도 연구.” 『상담학연구』, 제13권 제1호. pp. 113-133.
- 정충신. (2022. 9. 15.). “복무부적합 중도 전역병사 ‘5년간 3개 사단’ 규모...병력 수급 차질 우려.” 『문화일보』. <https://munhwa.com/news/view.html?no=2022091501039930114003>.

- 정현희·조현주·노승혜. (2022). “자기비난 방식 척도(Form of Self-Criticism Scale: FSCS) 개발 및 타당화.” 『한국심리학회지: 건강』, 제27권 제4호. pp. 719-741.
- 조성신. (2023. 10. 5.). “군인 자살 최근 5년간 320명...“간부가 장병보다 더 많아”. 『매일경제』. <https://www.mk.co.kr/news/politics/10843000>
- 최병욱·임유신. (2015). “초급간부 운영체제의 효율성 향상을 위한 중장기 정책방향.” 『국방정책연구』, 제30권 제4호. pp. 7-27.
- 최정민·변기환·임현우·조진진·박종익. (2021). “대한민국 군간부에서의 자살 위험성에 대한 위험 요인과 보호 요인.” 『Journal of Korean Neuropsychiatric Association』, 제60권 제4호. pp. 339-345.
- 최지영·이민규. (2016). “감사성향, 정서조절곤란, 우울이 수행자의 자살생각에 미치는 영향.” 『교정복지연구』, 제42권. pp. 159-186.
- 최현주·이자영. (2012). “직업군인(부사관)의 소진 경험에 대한 질적 연구.” 『상담학연구』, 제13권 제6호. pp. 2777-2802.
- 현혜순·김태열·김윤영. (2018). “베트남 참전군인의 외상 후 스트레스와 사회적 지지가 우울에 미치는 영향.” 『보건의료산업학회지』, 제12권 제1호. pp. 137-147.
- 황지현·채정호. (2017). “우울장애 환자의 자살사고에 우울, 낙관성과 감사성향이 미치는 영향.” 『Mood and Emotion』, 제15권 제3호. pp. 123-129.
- 홍점동·양난미. (2013). “군생활 스트레스가 자살생각에 미치는 영향: 자아존중감, 소외감, 욕구좌절의 매개효과.” 『상담학연구』, 제14권 제2호. pp. 1423-1441.
- 허태선·임정인·김준환·오상도. (2022). “군 간부의 직무스트레스가 자살생각에 미치는 영향 연구-알콜 의존도 매개효과와 회복탄력성 조절효과를 중심으로.” 『소비문화연구』, 제25권 제2호. pp. 201-222.
- (주)휴노. (2023). 군 간부 및 군무원 민간 심리상담 지원 프로그램. 국방부 (<https://www.eap.co.kr/mnd/>). (검색일: 2024. 9. 5.).
- e-나라지표. (2024). 군 사망사고 현황. 지표누리(https://www.index.go.kr/unity/potal/main/EachDtlPageDetail.do?idx_cd=1701). (검색일: 2024. 9. 5.).
- Aldwin, C. M. (2007). *Stress, coping, and development: An integrative approach* (2nd ed.). New York: Guilford.
- Baumeister, R. F. (1990). “Suicide as escape from self.” *Psychological Review*, 97(1), 90-113.
- Bower, G. H. (1981). “Mood and memory.” *American Psychologist*, 36, 129-148.

- Caplan, G. (1974). *Support systems and community mental health: Lectures on concept development*. New York: Behavioral Publication.
- Dao, T. K., Lee, D., & Chang, H. L. (2007). "Acculturation level, perceived English fluency, perceived social support level, and depression among Taiwanese international students." *College Student Journal*, 41(2), 287-295.
- Emmons, R. A. (2007). *Thanks!: How the new science of gratitude can make you happier*. New York: Houghton Mifflin Harcourt.
- Emmons, R. A., & McCullough, M. E. (2003). "Counting blessings versus burdens: An experimental investigation of gratitude and subjective well-being in daily life." *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(2), 377-389.
- Fredrickson, B. L. (2001). "The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions." *American Psychologist*, 56(3), 218-226.
- Gabana, N. T., Wong, Y. J., D'Addario, A., & Chow, G. M. (2022). "The Athlete Gratitude Group (TAGG): Effects of coach participation in a positive psychology intervention with youth athletes." *Journal of Applied Sport Psychology*, 34(2), 229-250.
- Grossberg, A., & Rice, T. (2023). "Depression and suicidal behavior in adolescents." *Medical Clinics*, 107(1), 169-182.
- Howard, M. C. (2016). "A review of exploratory factor analysis decisions and overview of current practices: What we are doing and how can we improve?." *International Journal of Human-Computer Interaction*, 32(1), 51-62.
- Hu, F. H., Zhao, D. Y., Fu, X. L., Zhang, W. Q., Tang, W., Hu, S. Q., ... & Chen, H. L. (2023). "Effects of social support on suicide-related behaviors in patients with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis." *Journal of Affective Disorders*, 328, 324-333.
- Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). "Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives." *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1-55.
- Kashdan, T. B., Uswatte, G., & Julian, T. (2006). "Gratitude and hedonic and eudaimonic well-being in Vietnam war veterans." *Behaviour Research and Therapy*, 44(2),

177-199.

- Kim, P. Y., Britt, T. W., Klocko, R. P., Riviere, L. A., & Adler, A. B. (2011). "Stigma, negative attitudes about treatment, and utilization of mental health care among soldiers." *Military Psychology*, 23(1), 65-81.
- Lee, H., Aldwin, C. M., & Kang, S. (2022). "Do different types of war stressors have independent relations with mental health? Findings from the Korean Vietnam Veterans Study." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 14(5), 840-848.
- McCullough, M. E., Emmons, R. A., & Tsang, J. (2002). "The grateful disposition: A conceptual and empirical topography." *Journal of Personality & Social Psychology*, 82(1), 112-127.
- Osman, A., Bagge, C. L., Gutierrez, P. M., Konick, L. C., Kopper, B. A., & Barrios, F. X. (2001). "The Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised(SBQ-R): Validation with clinical and nonclinical samples." *Assessment*, 8(4), 443-454.
- Proescher, E., Aase, D. M., Passi, H. M., Greenstein, J. E., Schroth, C., & Phan, K. L. (2022). "Impact of perceived social support on mental health, quality of life, and disability in post-9/11 US military veterans." *Armed Forces & Society*, 48(1), 115-135.
- Richard, J., Fletcher, E., Boutin, S., Derevensky, J., & Temcheff, C. (2020). "Conduct problems and depressive symptoms in association with problem gambling and gaming: A systematic review." *Journal of Behavioral Addictions*, 9(3), 497-533.
- Roohafza, H. R., Afshar, H., Keshteli, A. H., Mohammadi, N., Feizi, A., Taslimi, M., & Adibi, P. (2014). "What's the role of perceived social support and coping styles in depression and anxiety?." *Journal of Research in Medical Sciences*, 19(10), 944-949.
- Shinetsetseg, O., Jung, Y. H., Park, Y. S., Park, E. C., & Jang, S. Y. (2022). "Association between smartphone addiction and suicide." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(18), 1-11.
- Shrestha, N. (2020). "Detecting multicollinearity in regression analysis." *American Journal of Applied Mathematics and Statistics*, 8(2), 39-42.
- Scoglio, A. A., Molnar, B. E., Lincoln, A. K., Griffith, J., Park, C. L., & Kraus, S. W.

- (2023). "Social support over time for men and women veterans with and without complex trauma histories." *Psychological Services*, 20(3), 516-524.
- Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Patient Health Questionnaire Primary Care Study Group. (1999). "Validation and utility of a self-report version of PRIME-MD: The PHQ primary care study." *JAMA*, 282(18), 1737-1744.
- Vandenberg, R. J., & Lance, C. E. (2000). "A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research." *Organizational Research Methods*, 3(1), 4-70.
- Watkins, P. C., Grimm, D. L., & Kolts, R. (2004). "Counting your blessings: Positive memories among grateful persons." *Current Psychology*, 23, 52-67.
- Watters, E. R., Aloe, A. M., & Wojciak, A. S. (2023). "Examining the associations between childhood trauma, resilience, and depression: A multivariate meta-analysis." *Trauma, Violence, & Abuse*, 24(1), 231-244.
- Wilcox, S. (2010). "Social relationships and PTSD symptomatology in combat veterans." *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 2(3), 175-182.
- Wilson, J., Jones, M., Fear, N. T., Hull, L., Hotopf, M., Wessely, S., & Rona, R. J. (2009). "Is previous psychological health associated with the likelihood of Iraq War deployment? An investigation of the "healthy warrior effect"." *American Journal of Epidemiology*, 169(11), 1362-1369.
- Wood, A. M., Joseph, S., & Maltby, J. (2009). "Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets." *Personality and Individual Differences*, 46(4), 443-447.

부록 1. 군 간부 스트레스 척도 (최초 30개 문항)

1. 많은 업무량으로 인해 연장근무나 야근이 잦아 스트레스를 느낀다.
2. 자신의 업무가 아닌 다른 업무까지 맡게 되어 스트레스를 느낀다.
3. 업무가 체계적이지 않거나 지침이 자주 변경되어 스트레스를 느낀다.
4. 위험한 업무수행으로 스트레스를 느낀다.
5. 업무가 체력적으로 부담이 많아 스트레스를 느낀다.
6. 일과 이후에도 임무 대기 상태를 유지하거나 위수지역을 준수해야 하는 것에 스트레스를 느낀다.
7. 상명하복을 강조하는 경직된 조직문화로 인해 스트레스를 느낀다.
8. 지나치게 성과와 실적을 강조하는 분위기 때문에 스트레스를 느낀다.
9. 군에서의 미래(진급, 장기선발 등)가 불안정하고 예측하기 어려워서 스트레스를 느낀다.
10. 문제의 근본적인 해결보다는 보여주기식의 문화가 팽배하여 스트레스를 느낀다.
11. 불공정한 인사 평정과 진급으로 인해 스트레스를 느낀다.
12. 노력에 비해 충분하지 않은 봉급으로 인해 스트레스를 느낀다.
13. 출·퇴근 거리가 멀거나 교통수단의 제한으로 스트레스를 느낀다.
14. 거주환경이 열악해서 스트레스를 느낀다.
15. 문화적, 의료적 제약이 많아 스트레스를 느낀다.
16. 상관 또는 상급자와의 관계로 인해 스트레스를 느낀다.
17. 동료와의 관계로 인해 스트레스를 느낀다.
18. 부하나 하급자를 관리/지도하는 것에 대해 스트레스를 느낀다.
19. 부대 내 원활한 의사소통이 이루어지지 않아 스트레스를 받는다.
20. 마음을 터놓고 대화할 사람이 없어 스트레스를 느낀다.
21. 가족(또는 연인)과 떨어져 지내서 스트레스를 느낀다.
22. (미혼일 경우) 결혼 준비 여건이 열악하여 스트레스를 느낀다./
(기혼일 경우) 일-가정 균형을 맞추기 어려워 스트레스를 느낀다.
23. 가족의 기념일, 경조사 등을 챙길 수 없어 스트레스를 느낀다.
24. 가족의 정신건강 문제를 잘 해결해 줄 수 없어 스트레스를 느낀다.
25. 부모님을 찾아뵙지 못하거나 자녀 교육문제로 스트레스를 느낀다.
26. 나의 건강문제로 인해 스트레스를 느낀다.
27. 수면 부족으로 인해 스트레스를 느낀다.
28. 개인적인 채무문제로 인해 스트레스를 느낀다.
29. 온라인 게임이나 스마트폰 사용을 절제할 수 없어 스트레스를 느낀다.
30. 인터넷 도박이나 사행성 도박 등을 절제할 수 없어 스트레스를 느낀다.

부록 2. 군 간부 스트레스 척도 (최종 28개 문항)

업무	1. 많은 업무량으로 인해 연장근무나 야근이 잦아 스트레스를 느낀다.
	2. 자신의 업무가 아닌 다른 업무까지 맡게 되어 스트레스를 느낀다.
	4. 위험한 업무수행으로 스트레스를 느낀다.
	5. 업무가 체력적으로 부담이 많아 스트레스를 느낀다.
	3. 업무가 체계적이지 않거나 지침이 자주 변경되어 스트레스를 느낀다.
조직 문화	6. 일과 이후에도 임무 대기 상태를 유지하거나 위수지역을 준수해야 하는 것에 스트레스를 느낀다.
	8. 지나치게 성과와 실적을 강조하는 분위기 때문에 스트레스를 느낀다.
	9. 군에서의 미래(진급, 장기선발 등)가 불안정하고 예측하기 어려워서 스트레스를 느낀다.
	10. 문제의 근본적인 해결보다는 보여주기식의 문화가 팽배하여 스트레스를 느낀다.
	11. 불공정한 인사 평정과 진급으로 인해 스트레스를 느낀다.
	12. 노력에 비해 충분하지 않은 봉급으로 인해 스트레스를 느낀다.
	19. 부대 내 원활한 의사소통이 이루어지지 않아 스트레스를 받는다.
근무 환경	13. 출·퇴근 거리가 멀거나 교통수단의 제한으로 스트레스를 느낀다.
	14. 거주환경이 열악해서 스트레스를 느낀다.
	15. 문화적, 의료적 제약이 많아 스트레스를 느낀다.
대인 관계	7. 상명하복을 강조하는 경직된 조직문화로 인해 스트레스를 느낀다.
	16. 상관 또는 상급자와의 관계로 인해 스트레스를 느낀다.
	17. 동료와의 관계로 인해 스트레스를 느낀다.
	18. 부하나 하급자를 관리/지도하는 것에 대해 스트레스를 느낀다.
	20. 마음을 터놓고 대화할 사람이 없어 스트레스를 느낀다.
가족	21. 가족(또는 연인)과 떨어져 지내서 스트레스를 느낀다.
	22. (미혼일 경우) 결혼 준비 여건이 열악하여 스트레스를 느낀다./ (기혼일 경우) 일-가정 균형을 맞추기 어려워 스트레스를 느낀다.
	23. 가족의 기념일, 경조사 등을 챙길 수 없어 스트레스를 느낀다.
	24. 가족의 정신건강 문제를 잘 해결해 줄 수 없어 스트레스를 느낀다.
	25. 부모님을 찾아뵙지 못하거나 자녀 교육문제로 스트레스를 느낀다.
개인	26. 개인적인 채무문제로 인해 스트레스를 느낀다.
	27. 온라인 게임이나 스마트폰 사용을 절제할 수 없어 스트레스를 느낀다.
	28. 인터넷 도박이나 사행성 도박 등을 절제할 수 없어 스트레스를 느낀다.

부록 3. 연구변수의 기술통계 결과

구분	평균(<i>M</i>)	표준편차(<i>SD</i>)	범위(Range) ^{a)}
나이	30.04	7.41	18 ~ 52
성별(남=1, 여=2)	1.13	0.33	1, 2
교육수준	1.89	0.47	1 ~ 3
결혼상태(독신=1, 기혼/사실혼=2)	1.38	0.48	1, 2
신분(초급간부=1, 중견간부=2)	1.40	0.49	1, 2
스트레스 총점	40.67	20.96	0 ~ 100
업무 스트레스	5.51	3.60	0 ~ 16
조직환경 스트레스	16.37	7.81	0 ~ 32
근무환경 스트레스	4.37	3.27	0 ~ 12
대인관계 스트레스	5.55	4.60	0 ~ 20
가족 스트레스	8.10	5.97	0 ~ 20
개인 스트레스	.77	1.27	0 ~ 6
자살 행동	3.58	1.61	3 ~ 15
우울증	4.20	4.59	0 ~ 27
감사성향	33.01	6.65	8 ~ 42
사회적 지지	67.40	10.89	24 ~ 80
사회적 바람직성	5.98	2.00	0 ~ 8

참고. a) 최솟값 ~ 최댓값.

부록 4. 스트레스(28개 문항)가 자살 행동과 우울증에 미치는 영향

종속변수		자살 행동					
		전체(N=500)		초급간부(N=300)		중견간부(N=200)	
		B(SE)	β	B(SE)	β	B(SE)	β
통제변수	나이	-.00(.01)	-.04	-.03(.03)	-.07	-.01(.02)	.01
	성별	.43(.21)	.09*	.23(.27)	.05	.78(.34)	.15*
	결혼상태	.11(.20)	.03	.33(.28)	.08	.02(.28)	.01
스트레스	전체(28개 문항)	.01(.00)	.13**	.01(.01)	.10	.02(.01)	.20**
보호요인	감사성향	-.02(.01)	-.09	-.01(.01)	-.01	-.06(.02)	-.26**
	사회적 지지	-.02(.01)	-.13*	-.03(.01)	-.22**	.01(.01)	.06
	R ²	.08, F(6,493)=7.49***		.07, F(6,293)=3.88**		.15, F(6,193)=5.62**	

종속변수		우울증					
		전체(N=500)		초급간부(N=300)		중견간부(N=200)	
		B(SE)	β	B(SE)	β	B(SE)	β
통제변수	나이	-.08(.03)	-.14**	-.18(.08)	-.12*	-.01(.04)	-.01
	성별	.69(.53)	.05	-.11(.70)	-.01	2.16(.80)	.16**
	결혼상태	.09(.49)	.01	.81(.75)	.06	-.22(.66)	-.02
스트레스	전체(28개 문항)	.08(.01)	.36***	.09(.01)	.38***	.08(.01)	.36***
보호요인	감사성향	-.10(.03)	-.15**	-.08(.04)	-.12+	-.11(.05)	-.18**
	사회적 지지	-.07(.02)	-.16**	-.08(.03)	-.20**	-.05(.03)	-.12
	R ²	.28, F(6,493)=30.50***		.27, F(6,293)=18.38***		.33, F(6,193)=15.86***	

참고. + $p=.05$. * $p<.05$. ** $p<.01$. *** $p<.001$.